Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 3 · octobre 2026
p. 64–67 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT

S'exercer à la rencontre

L'intelligence artificielle dans la formation des psychothérapeutes et des conseillers : clients simulés, rétroaction sur les compétences et supervision

Sora Pazer, Samuel R. Ashford et Eleanor M. Whitcombe
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

La formation à la psychothérapie et au counseling repose depuis longtemps sur les jeux de rôle, les séances enregistrées et la supervision, mais les occasions structurées de pratique répétée assortie d'une rétroaction spécifique demeurent rares. Les progrès du traitement automatique du langage naturel et des grands modèles de langage ont donné naissance à deux familles d'outils qui répondent à cette lacune : des clients simulés avec lesquels les personnes en formation peuvent répéter des entretiens, et des systèmes automatisés qui codent les énoncés et fournissent une rétroaction sur des compétences telles que les questions ouvertes, les reflets et les réponses empathiques. Cet article à visée pratique expose la justification didactique de tels outils dans le cadre de la pratique délibérée, résume les données disponibles issues d'études de faisabilité et d'essais randomisés menés auprès d'échantillons de non-thérapeutes et de pairs aidants, et illustre leur utilisation à l'aide d'une vignette pédagogique construite. Il en discute ensuite les limites : les clients simulés peuvent être d'une coopération invraisemblable, stéréotypés ou incohérents ; la rétroaction automatisée saisit plus aisément les comportements dénombrables que la qualité relationnelle ; et les enregistrements soulèvent des questions de consentement et de protection des données. Dans une perspective centrée sur le sens, l'article soutient que les outils d'IA peuvent utilement entraîner la technique, mais ne sauraient remplacer les rencontres supervisées avec des personnes réelles. Des recommandations relatives à l'intégration dans les cursus, à la transparence et à l'évaluation sont formulées.

Mots-clés : intelligence artificielle · formation en psychothérapie · clients simulés · pratique délibérée · supervision clinique

ABSTRACT

Training in psychotherapy and counseling has long relied on role-plays, recorded sessions, and supervision, yet structured opportunities for repeated practice with specific feedback remain scarce. Advances in natural language processing and large language models have produced two families of tools that address this gap: simulated clients with whom trainees can rehearse conversations, and automated systems that code utterances and return feedback on skills such as open questions, reflections, and empathic responding. This practice-oriented article outlines the didactic rationale for such tools within the framework of deliberate practice, summarizes the available evidence from feasibility studies and randomized trials with nontherapist and peer samples, and illustrates their use in a constructed teaching vignette. It then discusses their limits: simulated clients may be implausibly cooperative, stereotyped, or inconsistent; automated feedback captures countable behaviors more readily than relational quality; and recordings raise questions of consent and data protection. From a meaning-centered perspective, the article argues that AI tools can usefully train technique but cannot replace supervised encounters with real persons. Recommendations for curriculum integration, transparency, and evaluation are offered.

Keywords: artificial intelligence · psychotherapy training · simulated clients · deliberate practice · clinical supervision

1 Introduction

Apprendre à mener des entretiens psychothérapeutiques constitue l'apprentissage d'une compétence interpersonnelle exigeante. Les personnes en formation doivent apprendre à écouter, à poser des questions ouvertes, à refléter le sens et l'émotion, à supporter le silence et à répondre à la détresse sans perdre pied. Les cursus traditionnels

enseignent ces compétences au moyen de cours magistraux, de jeux de rôle entre pairs, de l'observation de séances enregistrées et du travail clinique supervisé. Chacun de ces formats a sa valeur, mais tous partagent une limite pratique : les occasions d'exercer une compétence précise de manière répétée, avec une rétroaction rapide et spécifique, sont rares et coûteuses (Tanana et al., 2019).

Au cours de la dernière décennie, des méthodes computationnelles ont commencé à s'attaquer à ce goulet d'étranglement. Des équipes de recherche ont développé des systèmes qui codent automatiquement les énoncés des thérapeutes en entretien motivationnel (Atkins et al., 2014 ; Flemotomos et al., 2022), des outils de rétroaction qui synthétisent ces codes à l'intention des cliniciens (Imel et al., 2019), ainsi que des agents conversationnels qui jouent le rôle d'un client (Tanana et al., 2019). Les grands modèles de langage ont considérablement élargi ces possibilités (Stade et al., 2024). Le présent article examine ce que ces outils peuvent apporter à la formation, où se situent leurs limites et comment ils pourraient être intégrés dans les cursus d'une manière qui reste fidèle au cœur relationnel et existentiel de la psychothérapie.

2 Pratique, rétroaction et développement de l'expertise

L'argument didactique en faveur d'une formation assistée par l'IA repose largement sur le concept de pratique délibérée : la répétition exigeante et réitérée de sous-compétences bien définies, légèrement au-delà de son niveau actuel, accompagnée d'une rétroaction immédiate et de possibilités de correction (Ericsson et al., 1993). Rousmaniere (2017) a transposé ce concept à la psychothérapie, en proposant que les thérapeutes répètent les moments difficiles, comme répondre à l'hostilité ou à l'expression du désespoir, dans des exercices brefs et reproductibles, plutôt que d'attendre que de tels moments surviennent lors de séances réelles.

Deux ensembles de données rendent cette approche attrayante. Premièrement, les études sur l'expérience clinique suggèrent que les thérapeutes ne deviennent pas automatiquement plus efficaces avec le temps ; dans un vaste ensemble de données naturalistes, Goldberg et al. (2016) ont rapporté que les résultats des clients ne s'amélioraient pas, en moyenne, avec l'expérience des thérapeutes, et qu'ils diminuaient même légèrement. Deuxièmement, les recherches sur la formation à l'entretien motivationnel ont indiqué qu'un atelier seul produisait des gains de compétence modestes et en partie instables, tandis que l'ajout de rétroaction et d'accompagnement était associé à un meilleur maintien des compétences (Miller et al., 2004). Autrement dit, la rétroaction n'est pas un complément facultatif mais un mécanisme central de l'apprentissage, et c'est précisément elle qui fait défaut.

3 Clients simulés : du jeu de rôle scénarisé aux modèles de langage

Les clients simulés ont une longue histoire dans la formation clinique, notamment sous la forme d'acteurs formés et de patients standardisés. Les premières versions computationnelles étaient fondées sur des règles ou sur la récupération de réponses. Un exemple bien documenté est ClientBot, un agent textuel entraîné sur une vaste archive de transcriptions de psychothérapie, qui répond comme un client et fournit aux personnes en formation une rétroaction sur leur usage des questions ouvertes et des reflets (Tanana et al., 2019). Dans une évaluation randomisée menée auprès de participants non thérapeutes, ceux qui s'exerçaient avec une rétroaction immédiate utilisaient nettement plus souvent des reflets qu'un groupe témoin n'ayant reçu qu'une information et des encouragements, et ce tant pendant l'exercice qu'après le retrait de la rétroaction (Tanana et al., 2019).

Les grands modèles de langage permettent de générer des clients dotés d'histoires détaillées, de degrés variables d'ambivalence et de styles de communication différents, et d'ajuster la difficulté à la demande. Une personne en formation peut, par exemple, demander à la simulation d'incarner un client qui réagit à un conseil prématuré par le retrait. Cette flexibilité est précieuse sur le plan pédagogique, car elle permet une exposition répétée à des situations cliniquement difficiles qui sont rares, éthiquement délicates ou imprévisibles dans la pratique réelle.

Cette même flexibilité engendre de nouveaux problèmes. Les modèles de langage produisent un texte statistiquement plausible sans compréhension ni expérience vécue (Bender et al., 2021). Les clients simulés peuvent donc se montrer d'une éloquence, d'une coopération ou d'une rapidité de prise de conscience irréalistes ; ils peuvent reproduire des stéréotypes culturels ou diagnostiques présents dans leurs données d'entraînement ; et ils peuvent sortir de leur rôle au fil d'un entretien prolongé. Les enseignants devraient donc considérer les clients simulés comme des exercices dont l'artificialité est connue, et non comme des modèles fidèles de patients.

4 Rétroaction automatisée sur les compétences conversationnelles

Une seconde famille d'outils analyse ce que dit la personne en formation. S'appuyant sur des systèmes de codage comportemental de l'entretien motivationnel, des modèles d'apprentissage automatique ont été entraînés à classer les énoncés, par exemple en questions ouvertes ou fermées, en reflets simples ou complexes, ou en réponses compatibles ou non avec l'entretien motivationnel (Atkins et al., 2014). Des travaux ultérieurs ont combiné reconnaissance de la parole, identification des locuteurs et modèles de langage afin d'estimer ces codes et des indicateurs au niveau de la séance directement à partir d'enregistrements audio (Flemotomos et al., 2022). Dans une étude de faisabilité, Imel et al. (2019) ont rapporté qu'un rapport de rétroaction automatisé fondé sur de tels codes pouvait être fourni à des conseillers et qu'il était globalement reçu comme acceptable et compréhensible.

Des travaux apparentés ont exploré la rétroaction sur l'empathie. Dans une étude randomisée menée sur une plateforme textuelle de soutien entre pairs, Sharma et al. (2023) ont rapporté que les pairs aidants qui recevaient des suggestions générées par l'IA pour reformuler leurs réponses produisaient des échanges jugés plus empathiques que ceux des pairs aidants ne bénéficiant pas de cette aide. Bien que les pairs aidants ne soient pas des psychothérapeutes, l'étude illustre un mécanisme pertinent pour la formation : une rétroaction délivrée au moment de la formulation, que la personne aidante reste libre d'accepter, d'adapter ou de rejeter.

La rétroaction automatisée est la plus fiable pour les comportements qui peuvent être dénombrés et définis au niveau d'énoncés isolés. Les qualités relationnelles telles que le sens du moment, la chaleur, la présence ou la capacité de demeurer auprès du désespoir d'un client sont bien plus difficiles à opérationnaliser. Le risque existe que ce qui est mesurable devienne ce qui est enseigné : les personnes en formation pourraient apprendre à augmenter le nombre de leurs reflets sans approfondir leur compréhension de la personne qui leur fait face.

5 Une vignette pédagogique construite

La vignette suivante est fictive et a été construite à des fins d'enseignement ; elle ne décrit ni des personnes ni des données réelles. Une étudiante de deuxième année d'un programme de counseling s'exerce avec un client simulé reposant sur un modèle de langage, décrit comme un homme d'une cinquantaine d'années qui a récemment perdu son emploi et affirme que plus rien de ce qu'il fait n'a d'importance. Lors du premier essai, l'étudiante répond rapidement par des paroles rassurantes et des suggestions de candidatures. Le client simulé devient laconique. Un panneau de rétroaction automatisée relève de nombreuses questions fermées et peu de reflets.

Lors d'un second essai, l'étudiante ralentit, reflète le sentiment de futilité du client et lui demande ce qui donnait autrefois de la signification à son travail. La simulation répond par des propos plus élaborés. Lors de la supervision de groupe qui suit, la superviseure ne se contente toutefois pas de saluer le nombre plus élevé de reflets. Le groupe examine plutôt ce que l'exercice ne pouvait pas montrer : comment le propre malaise de l'étudiante face au désespoir a nourri sa hâte initiale à conseiller, comment un client réel aurait pu réagir par le silence ou la colère, et comment une question portant sur le sens ne peut ouvrir un dialogue socratique que si elle est posée avec un intérêt authentique et non comme une technique (Frankl, 1969). La simulation a servi de matériau à la réflexion ; l'apprentissage a eu lieu dans la conversation humaine à son sujet.

6 Limites didactiques, supervision et garde-fous éthiques

Plusieurs limites découlent de la discussion qui précède. Les données demeurent préliminaires : la plupart des études portent sur des participants non thérapeutes, des pairs aidants ou de courtes périodes d'exposition, et les résultats sont généralement mesurés comme des comportements de compétence lors d'exercices plutôt que comme des résultats cliniques chez des clients dans des traitements ultérieurs (Stade et al., 2024 ; Tanana et al., 2019). Le transfert de la simulation vers des séances réelles n'est pas établi.

La supervision ne peut être déléguée à ces outils. Elle ne porte pas seulement sur les techniques, mais sur le développement de la personne en formation en tant que personne, sur le contre-transfert, le jugement éthique et la responsabilité envers des clients réels. La rétroaction automatisée peut enrichir la supervision en offrant une base de discussion commune et concrète, mais elle ne saurait remplacer le jugement du superviseur ni la relation au sein de laquelle se forme l'identité professionnelle (Bennett-Levy, 2006).

Des garde-fous éthiques et juridiques sont également nécessaires. Les enregistrements de séances réelles utilisés pour la rétroaction automatisée

contiennent des informations de santé hautement sensibles ; les clients doivent donner leur consentement éclairé, et le traitement des données doit respecter le droit applicable en matière de protection des données. Les outils commerciaux devraient être examinés quant au lieu de stockage des données et à leur éventuelle utilisation pour entraîner des modèles. Les personnes en formation devraient être informées de l'artificialité et des biais possibles des clients simulés, et les programmes devraient évaluer leurs outils plutôt que de présumer leur efficacité.

Dans une perspective centrée sur le sens, un point supplémentaire mérite d'être souligné. La logothérapie conçoit la rencontre thérapeutique comme une rencontre entre personnes, dans laquelle le thérapeute accompagne la recherche de sens du client sans la prescrire (Frankl, 1969). Un client simulé n'a aucun sens à trouver ni aucune liberté de prendre position. S'exercer avec des simulations peut affiner l'attention et la technique, mais la dimension existentielle de la rencontre ne peut s'apprendre qu'au contact de personnes réelles et par une réflexion sur sa propre attitude face à la souffrance.

7 Conclusion

Les clients simulés fondés sur l'IA et les systèmes de rétroaction automatisée offrent une voie prometteuse pour étendre la pratique délibérée dans la formation des psychothérapeutes et des conseillers. Leurs limites tiennent à leur artificialité, à un biais en faveur du mesurable, à une base de données probantes encore mince et à des risques pour la confidentialité. Les programmes qui les intègrent devraient le faire en toute transparence, en complément du jeu de rôle, du travail clinique et de la supervision, et en évaluer les effets sur la compétence et, en définitive, sur les soins aux clients. Ainsi utilisée, la machine peut devenir une partenaire d'entraînement, tandis que la rencontre demeure une tâche humaine.

Références

Atkins, D. C., Steyvers, M., Imel, Z. E., & Smyth, P. (2014). Scaling up the evaluation of psychotherapy: Evaluating motivational interviewing fidelity via statistical text classification. Implementation Science, 9, Article 49. https://doi.org/10.1186/1748-5908-9-49

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610–623). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Bennett-Levy, J. (2006). Therapist skills: A cognitive model of their acquisition and refinement. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 34(1), 57–78. https://doi.org/10.1017/S1352465805002420

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363–406. https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363

Flemotomos, N., Martinez, V. R., Chen, Z., Singla, K., Ardulov, V., Peri, R., Caperton, D. D., Gibson, J., Tanana, M. J., Georgiou, P., Van Epps, J., Lord, S. P., Hirsch, T., Imel, Z. E., Atkins, D. C., & Narayanan, S. (2022). Automated evaluation of psychotherapy skills using speech and language technologies. Behavior Research Methods, 54(2), 690–711. https://doi.org/10.3758/s13428-021-01623-4

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Goldberg, S. B., Rousmaniere, T., Miller, S. D., Whipple, J., Nielsen, S. L., Hoyt, W. T., & Wampold, B. E. (2016). Do psychotherapists improve with time and experience? A longitudinal analysis of outcomes in a clinical setting. Journal of Counseling Psychology, 63(1), 1–11. https://doi.org/10.1037/cou0000131

Imel, Z. E., Pace, B. T., Soma, C. S., Tanana, M., Hirsch, T., Gibson, J., Georgiou, P., Narayanan, S., & Atkins, D. C. (2019). Design feasibility of an automated, machine-learning based feedback system for motivational interviewing. Psychotherapy, 56(2), 318–328. https://doi.org/10.1037/pst0000221

Miller, W. R., Yahne, C. E., Moyers, T. B., Martinez, J., & Pirritano, M. (2004). A randomized trial of methods to help clinicians learn motivational interviewing. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(6), 1050–1062. https://doi.org/10.1037/0022-006X.72.6.1050

Rousmaniere, T. (2017). Deliberate practice for psychotherapists: A guide to improving clinical effectiveness. Routledge.

Sharma, A., Lin, I. W., Miner, A. S., Atkins, D. C., & Althoff, T. (2023). Human–AI collaboration enables more empathic conversations in text-based peer-to-peer mental health support. Nature Machine Intelligence, 5(1), 46–57. https://doi.org/10.1038/s42256-022-00593-2

Stade, E. C., Stirman, S. W., Ungar, L. H., Boland, C. L., Schwartz, H. A., Yaden, D. B., Sedoc, J., DeRubeis, R. J., Willer, R., & Eichstaedt, J. C. (2024). Large language models could change the future of behavioral healthcare: A proposal for responsible development and evaluation. npj Mental Health Research, 3, Article 12. https://doi.org/10.1038/s44184-024-00056-z

Tanana, M. J., Soma, C. S., Srikumar, V., Atkins, D. C., & Imel, Z. E. (2019). Development and evaluation of ClientBot: Patient-like conversational agent to train basic counseling skills. Journal of Medical Internet Research, 21(7), e12529. https://doi.org/10.2196/12529

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Pazer, S., Ashford, S. R., & Whitcombe, E. M. (2026). Practicing the Encounter: Artificial intelligence in the training of psychotherapists and counselors: simulated clients, skills feedback, and supervision. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(3), 64–67.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.